

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN Y PLACER (Q-LES-Q)

Eje IV: Calidad de Vida y Satisfacción • Medida Específica del Disfrute y Placer Cotidiano de Endicott

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Cuestionario de Calidad de Vida: Disfrute y Satisfacción (Q-LES-Q; Forma Abreviada SF).
Nombre Original	Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire (Q-LES-Q; Endicott et al., 1993).
Autores Originales	Jean Endicott, Ph.D., John Nee, Ph.D., Wilma Harrison, M.D. y Robert Blumenthal, M.D.
Adaptación Hispana	Bobes, González, Bousoño et al. (2001); Universidad de Oviedo / CIBERSAM, España.
Eje Clínico y Constructo	Eje IV: Funcionamiento y Calidad de Vida. Capacidad hedónica de disfrute y satisfacción vital.
Tipo de Instrumento	Autoinforme de 16 reactivos (versión breve Q-LES-Q-SF) con escala Likert de 5 puntos (1 a 5).
Población y Rango	Adultos (≥ 18 años) en población psiquiátrica ambulatoria y ensayos clínicos de psicofármacos.
Tiempo de Administración	3 a 5 minutos en administración breve y sencilla.
Régimen de Licencia	Uso clínico y académico abierto bajo citación formal / Derechos originales de Columbia University.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: EL DISFRUTE Y PLACER COMO OBJETIVO CLÍNICO

El **Q-LES-Q** fue diseñado por Jean Endicott y colaboradores (1993) en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Columbia con el objetivo explícito de superar el modelo biomédico tradicional centrado únicamente en la remisión del síntoma. La recuperación psiquiátrica genuina exige la **restauración de la capacidad hedónica de experimentar satisfacción y placer** en las áreas vitales ordinarias:

1. **Foco en el Disfrute Subjetivo Activo:** Evalúa no solo la capacidad de realizar una tarea, sino el grado de complacencia, deleite y gratificación afectiva que el paciente experimenta al llevarla a cabo.
2. **Sensibilidad Extrema a la Anhedonia:** Al capturar directamente el disfrute cotidiano, es uno de los instrumentos más sensibles para detectar la anhedonia residual persistente en pacientes tratados con antidepresivos que conservan apatía a pesar de la mejoría sintomática.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS (FORMA ABREVIADA SF: 16 ÍTEMS)

El **Q-LES-Q-SF** explora 14 áreas vitales específicas durante la última semana más 2 reactivos complementarios:

Área Vital Evaluada	Ítem SF	Contenido y Criterios Evaluados en el Q-LES-Q-SF
1. Salud Física y Vitalidad	Ítems 1 y 2	Satisfacción con la propia salud física y con el estado de ánimo subjetivo.
2. Ocupación y Tareas	Ítems 3 y 4	Disfrute y satisfacción en el trabajo remunerado y en el trabajo del hogar.
3. Vínculos Sociales y Ocio	Ítems 5 y 6	Satisfacción con relaciones sociales/amistades y con actividades de tiempo libre/ocio.
4. Dinámica Familiar y Pareja	Ítems 7 y 8	Satisfacción con las relaciones familiares y con la vida sexual/de pareja.
5. Autonomía y Movilidad	Ítems 9 y 10	Capacidad de desenvolverse en la vida diaria y libertad para desplazarse sin trabas.
6. Economía y Hábitat	Ítems 11 y 12	Satisfacción con la situación financiera personal y con las condiciones de la vivienda.
7. Bienestar Global	Ítems 13 y 14	Sensación general de bienestar y satisfacción global con la vida.
8. Reactivos Suplementarios	Ítems 15 y 16	Satisfacción con la medicación prescrita (ítem 15) y valoración de la salud global (ítem 16).

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO PSICOMÉTRICO EN ESPAÑA / LATAM

La validación española de Bobes et al. (2001; $N = 320$ pacientes con depresión y controles) acredita una fiabilidad clínica de referencia:

Propiedad Psicométrica	Coefficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Consistencia Interna (SF)	Alfa $\alpha = 0.90 - 0.93$	Excelente consistencia interna en la forma breve de 14 reactivos computables.
Estabilidad Test-Retest	CCI $r = 0.86 - 0.90$	Alta reproducibilidad en pacientes eutímicos en reevaluaciones a 2 semanas.
Sensibilidad Terapéutica	Tamaño efecto $d = 0.88$	Extraordinaria sensibilidad al cambio tras tratamiento farmacológico y psicoterapia.
Validez Convergente Negativa	$r = -0.72$ (HAM-D)	Fuerte correlación inversa con escalas de gravedad depresiva y anhedonia.
Validez de Criterio	$r = 0.76$ (SF-36)	Alta convergencia con los componentes sumarios mental y físico del SF-36.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÓMPUTO PORCENTUAL ESTANDARIZADO

- **Opciones de Respuesta:** Escala Likert de 5 niveles que abarca la última semana: Nada o muy mala (1), Rara vez o mala (2), A veces o regular (3), Frecuentemente o buena (4), Casi siempre o muy buena (5).
- **Cómputo Directo de la Puntuación:** Se suman únicamente los primeros 14 reactivos (los ítems 15 y 16 se analizan de forma cualitativa independiente), generando una Puntuación Directa (PD) de **14 a 70 puntos**:

$$\text{Puntuación Directa Q-LES-Q-SF} = \sum_{i=1}^{14} \text{Ítem}_i \quad (\text{Rango: 14 a 70 puntos})$$

- **Transformación Porcentual Estandarizada (0% a 100%):** La métrica clínica estándar universal del Q-LES-Q expresa el resultado como **porcentaje de la máxima puntuación posible**:

$$\text{Puntuación Porcentual (\% Q-LES-Q)} = \left(\frac{\text{Puntuación Directa} - 14}{56} \right) \times 100$$

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN DEL PLACER

Estratificación	Porcentaje %	Rango PD	Nivel de Disfrute y Estado Clínico
Normativo Salud	70% a 100%	53 a 70 pts	Capacidad hedónica plena; media de la población comunitaria sana (Bobes et al.).
Deterioro Leve	55% a 69%	45 a 52 pts	Reducción moderada de gratificación en áreas específicas; quejas laborales.
Déficit Clínico	40% a 54%	36 a 44 pts	Anhedonia manifiesta; deterioro claro del placer en la vida diaria.
Anhedonia Severa	< 40%	< 36 pts	Colapso de la satisfacción vital; afectación depresiva mayor invalidante.

CRITERIO DE REMISIÓN COMPLETA DE ANHEDONIA (% Q-LES-Q $\geq 70\%$):

En ensayos clínicos y guías de tratamiento de depresión, se considera que un paciente ha alcanzado la **remisión funcional completa** si y solo si su puntuación porcentual en el Q-LES-Q alcanza o supera el **70%** (correspondiente a la media de la población comunitaria sana).

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE MONITORIZACIÓN HEDÓNICA EN TRASTORNOS DEL ESTADO DE ÁNIMO

PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO CON Q-LES-Q-SF:

- **Paso 1 (Línea Base en Episodio Depresivo / Distimia):** Aplicar antes de pautar tratamiento; típicamente se sitúa por debajo del 35%.
- **Paso 2 (Evaluación a las 6 Semanas):** Calcular la ganancia porcentual:
 - Si la puntuación permanece $< 50\%$, a pesar del descenso en Hamilton-D, sospechar anhedonia residual por embotamiento emocional inducido por ISRS; evaluar sustitución por bupropión o vortioxetina.
- **Paso 3 (Análisis del Ítem 15 - Medicación):** Si la satisfacción con la medicación es baja (≤ 2), explorar efectos secundarios sexuales, ganancia de peso o sedación diurna.
- **Paso 4 (Criterio de Alta Médica):** No suspender intervenciones psicoterapéuticas ni retirar fármacos hasta que el paciente consolide un porcentaje $\geq 70\%$ durante más de 3 meses.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: TRATAMIENTO DE ANHEDONIA RESIDUAL EN TRASTORNO BIPOLAR II

Identificación: Varón de 39 años, diseñador gráfico, en seguimiento ambulatorio por Trastorno Bipolar tipo II eutímico bajo tratamiento con litio y paroxetina. Manifiesta frustración porque, aunque no tiene crisis depresivas agudas, se siente "gris, incapaz de entusiasmarse con sus diseños y sin deseo sexual".

Evaluación Inicial Q-LES-Q-SF:

- **Puntuación Directa = 29 / 70 puntos (Porcentaje Q-LES-Q = 26.8% - Anhedonia Severa).**
- **Reactivos críticos:** Ítem 2 (Estado de ánimo) = 2/5; Ítem 3 (Trabajo) = 2/5; Ítem 6 (Ocio) = 1/5; Ítem 8 (Vida sexual) = 1/5; Ítem 15 (Satisfacción medicación) = 2/5.

Estrategia Terapéutica: Psiquiatría retiró gradualmente la paroxetina y añadió Lamotrigina en combinación con Litio a niveles terapéuticos controlados. En psicoterapia, se aplicó Activación Conductual focalizada en actividades con alto valor reforzante intrínseco.

Reevaluación a las 16 Semanas: La Puntuación Directa ascendió a **54 / 70 puntos (Porcentaje Q-LES-Q = 71.4% - Rango de Remisión Normativa)**. El paciente recuperó la creatividad profesional, reanudó una vida sexual plena y expresó genuino disfrute en sus aficiones fotográficas.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

ANHEDONIA PERSISTENTE Y RECAÍDA:

Un paciente que puntúa $< 40\%$ en el Q-LES-Q tras recibir el alta clínica presenta un riesgo 4 veces mayor de recaída depresiva mayor en los siguientes 6 meses; no dar el alta precozmente.

DISCRIMINACIÓN DE HEDONISMO MANÍACO:

Puntuaciones del 100% asociadas a hiperactividad no implican necesariamente bienestar saludable; pueden ser reflejo de un viraje hipomaniaco incipiente (evaluar con escala YMRS).

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Endicott, J., Nee, J., Harrison, W., & Blumenthal, R. (1993). Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire: A new measure. *Psychopharmacology Bulletin*, 29(2), 321-326.
2. Bobes, J., González, M. P., Bousoño, M., et al. (2001). Validación de la versión española del cuestionario Q-LES-Q de calidad de vida: Satisfacción y placer en pacientes con trastornos afectivos. *Actas Españolas de Psiquiatría*, 29(4), 225-233.
3. Stevanovic, D. (2011). Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire-Short Form for adolescents: Psychometric evaluation. *Quality of Life Research*, 20(9), 1531-1538.
4. Rapaport, M. H., et al. (2005). Quality of life impairment in depressive and anxiety disorders. *American Journal of Psychiatry*, 162(6), 1171-1178.